

Répétitoire Urologie

20 juin 2019

Une femme de 25 ans se plaint de cystites à répétition, plus de 4 épisodes annuels. L'examen des urines révèle la présence de leucocytes (+++) et la culture des urines montre la présence d'un *Proteus mirabilis*.

Quelle mesure envisagez-vous ?



A. Antibiothérapie de courte durée.



B. Antibiothérapie au long cours.



C. Investigation de la voie urinaire supérieure



D. Cystoscopie



E. Mesure du résidu post-mictionnel (ultrason)

Une femme de 25 ans se plaint de cystites à répétition, plus de 4 épisodes annuels. L'examen des urines révèle la présence de leucocytes (+++) et la culture des urines montre la présence d'un *Proteus mirabilis*.

Quelle mesure envisagez-vous ?

- ☐ A. Antibiothérapie de courte durée.
- ☐ B. Antibiothérapie au long cours.
- ☒ C. Investigation de la voie urinaire supérieure
- ☐ D. Cystoscopie
- ☐ E. Mesure du résidu post-mictionnel (ultrason)

Proteus mirabilis

- Gram-négatif qui produit de l'uréase
- L'uréase hydrolyse l'urée en 2 molécules d'ammoniac et 1 de CO_2 ; l'ammoniac est hydrolysé en ammonium et OH^- et le CO_2 en HCO_3^- puis en CO_3^{2-} , d'où il résulte une forte alcalinisation de l'urine.
- Formation de calcul de struvite
- Peut se rencontrer en présence d'une malformation urologique

Une femme de 89 ans, institutionnalisée en raison de déficits cognitifs importants sur une maladie d'Alzheimer, porteuse d'une sonde urinaire à demeure depuis 6 mois pour incontinence, est hospitalisée pour un état fébrile à 38⁰. La sonde urinaire a été changée la veille.

Quelle mesure envisagez-vous ?

- ☒ A. Culture d'urines et antibiothérapie 5 jours.
- ☐ B. Culture d'urines et antibiothérapie prophylactique.
- ☐ C. Cystoscopie
- ☐ D. CT-SCAN abdominal
- ☐ E. Lavage de la vessie

Une femme de 89 ans, institutionnalisée en raison de déficits cognitifs importants sur une maladie d'Alzheimer, porteuse d'une sonde urinaire à demeure depuis 6 mois pour incontinence, est hospitalisée pour un état fébrile à 38⁰. La sonde urinaire a été changée la veille.

Quelle mesure envisagez-vous ?



A. Culture d'urines et antibiothérapie 5 jours.



B. Culture d'urines et antibiothérapie prophylactique.



C. Cystoscopie



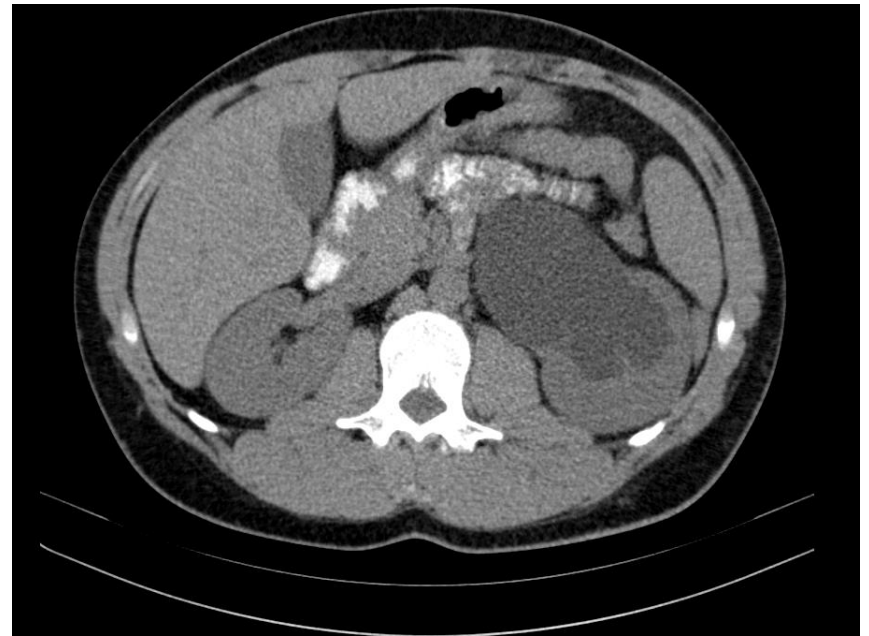
D. CT-SCAN abdominal



E. Lavage de la vessie

Pour la même personne, l'imagerie CT révèle ceci:

Quelle mesure envisagez-vous ?



A. Lomboscopie exploratrice



B. Antibiothérapie de 3 semaines



C. Urétéro-pyélographie rétrograde et mise en place d'une sonde JJ



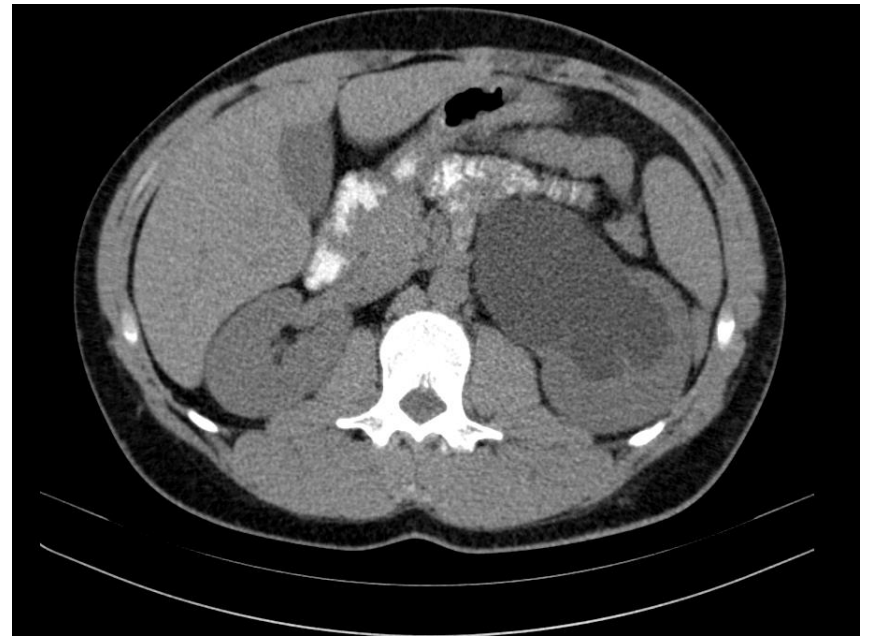
D. Scintigraphie rénale



E. Mise en place d'une néphrostomie sous contrôle échographique

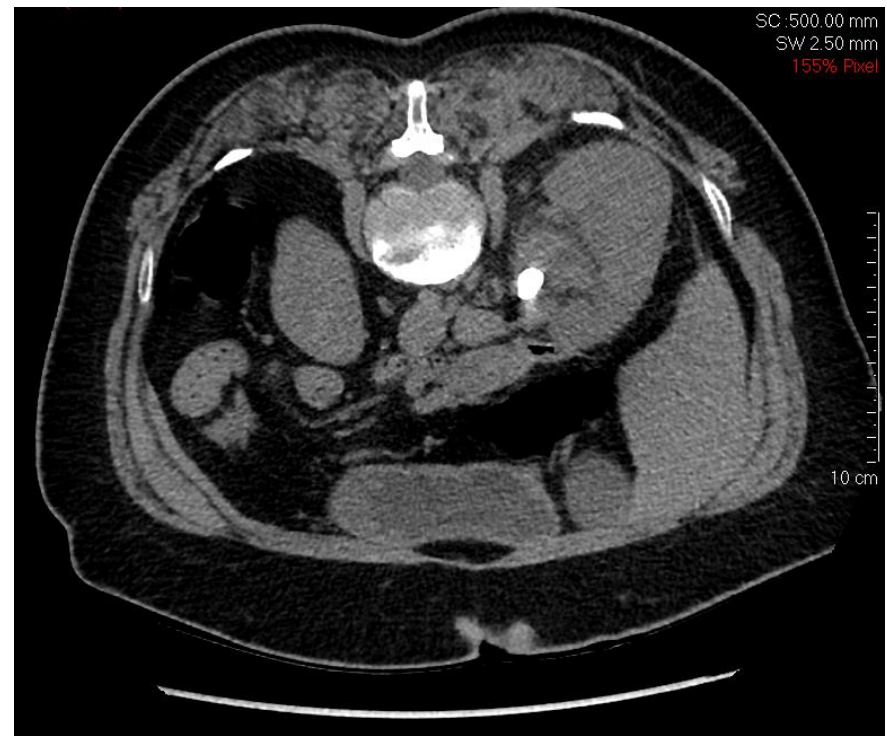
Pour la même personne, l'imagerie CT révèle ceci:

Quelle mesure envisagez-vous ?



- ☐ A. Lomboscopie exploratrice
- ☐ B. Antibiothérapie de 3 semaines
- ☐ C. Urétéro-pyélographie rétrograde et mise en place d'une sonde JJ
- ☐ D. Scintigraphie rénale
- ☒ E. Mise en place d'une néphrostomie sous contrôle échographique

Femme de 57 ans, admise aux urgences pour des douleurs en coliques du flanc droit, associées à un état fébrile. FSS: 15000 leuco. CRP: 289. Créatinine: 89. Urines: leuco ++++; E. Coli 10^6 , sensibles à tout. Imagerie CT natif: voir image



Quel diagnostic posez-vous ?



A. Pyélonéphrite droite



B. Pyélonephrite droite obstructive



C. Cancer du rein droit

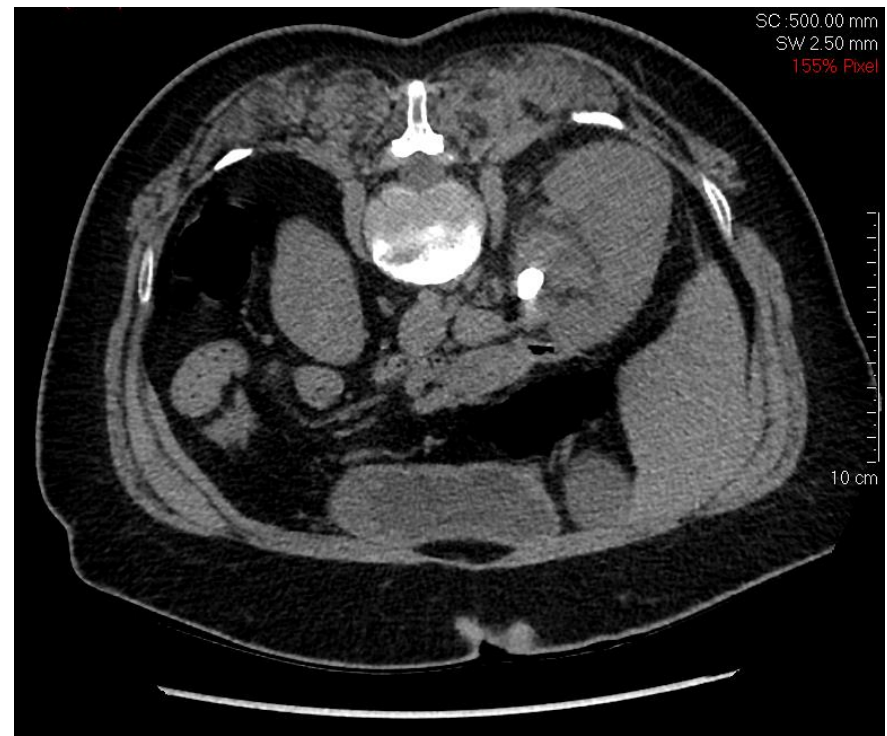


D. Malformation de la jonction pyélo-urétérale



E. Tumeur du bassinet

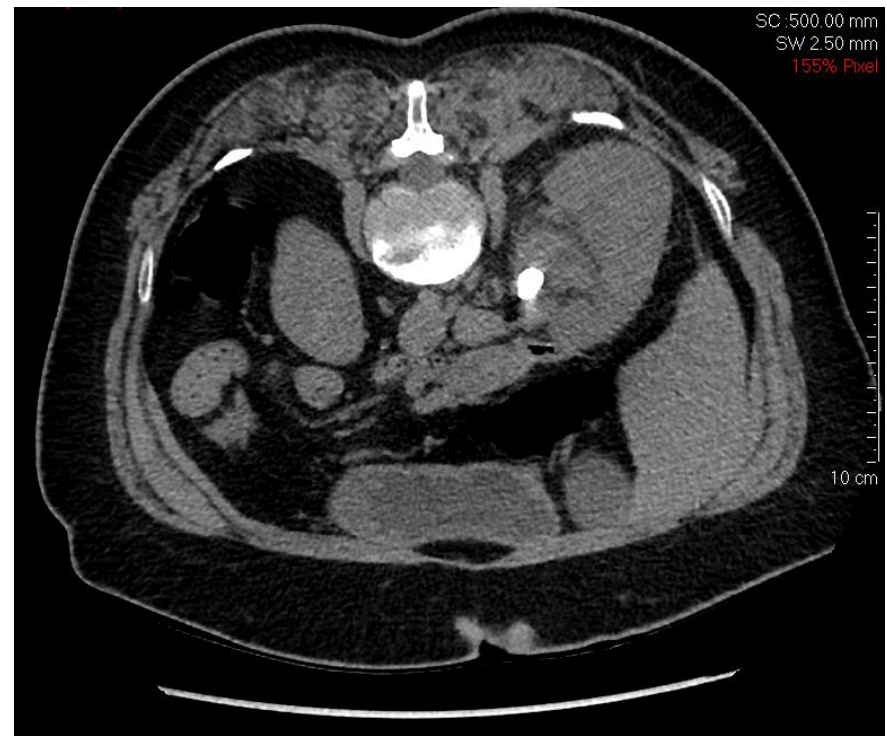
Femme de 57 ans, admise aux urgences pour des douleurs en coliques du flanc droit, associées à un état fébrile. FSS: 15000 leuco. CRP: 289. Créatinine: 89. Urines: leuco ++++; E. Coli 10^6 , sensibles à tout. Imagerie CT natif: voir image



Quel diagnostic posez-vous ?

- ☐ A. Pyélonéphrite droite
- ☒ B. Pyélonéphrite droite obstructive
- ☐ C. Cancer du rein droit
- ☐ D. Malformation de la jonction pyélo-urétérale
- ☐ E. Tumeur du bassinet

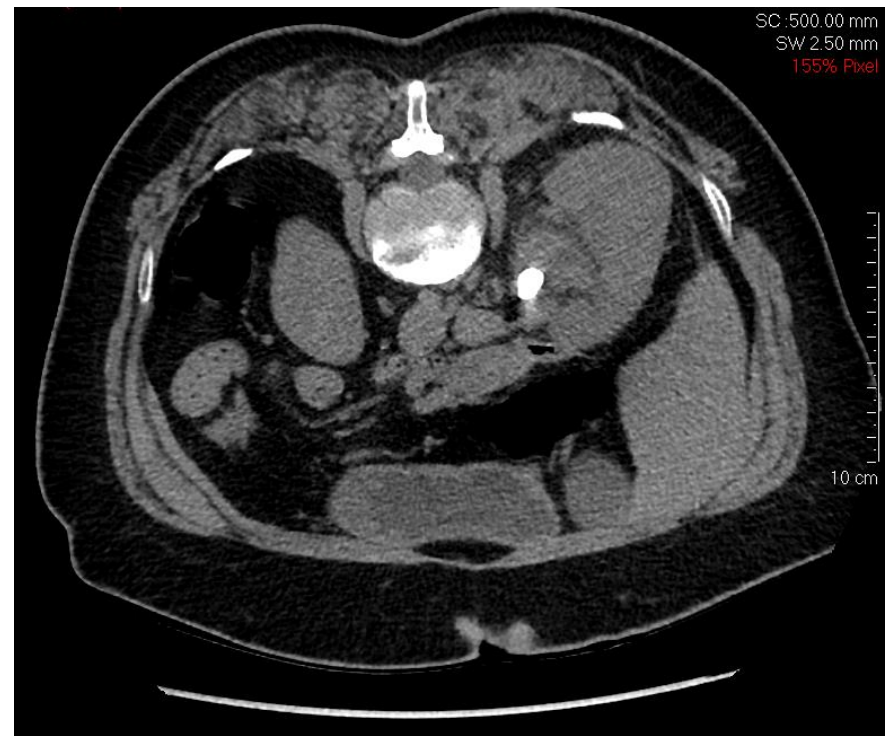
Femme de 57 ans, admise aux urgences pour des douleurs en coliques du flanc droit, associées à un état fébrile. FSS: 15000 leuco. CRP: 289. Créatinine: 89. Urines: leuco ++++; E. Coli 10^6 , sensibles à tout. Imagerie CT natif: voir image



Quelle mesure proposez-vous?

- ☐ A. Drainage urétéral : sonde JJ
- ☐ B. Pyélolithotomie différée après antibiothérapie
- ☐ C. Lithotritie extra-corporelle (ESWL)
- ☐ D. Néphrolitholapaxie percutanée
- ☐ E. Dissolution du calcul

Femme de 57 ans, admise aux urgences pour des douleurs en coliques du flanc droit, associées à un état fébrile. FSS: 15000 leuco. CRP: 289. Créatinine: 89. Urines: leuco ++++; E. Coli 10^6 , sensibles à tout. Imagerie CT natif: voir image

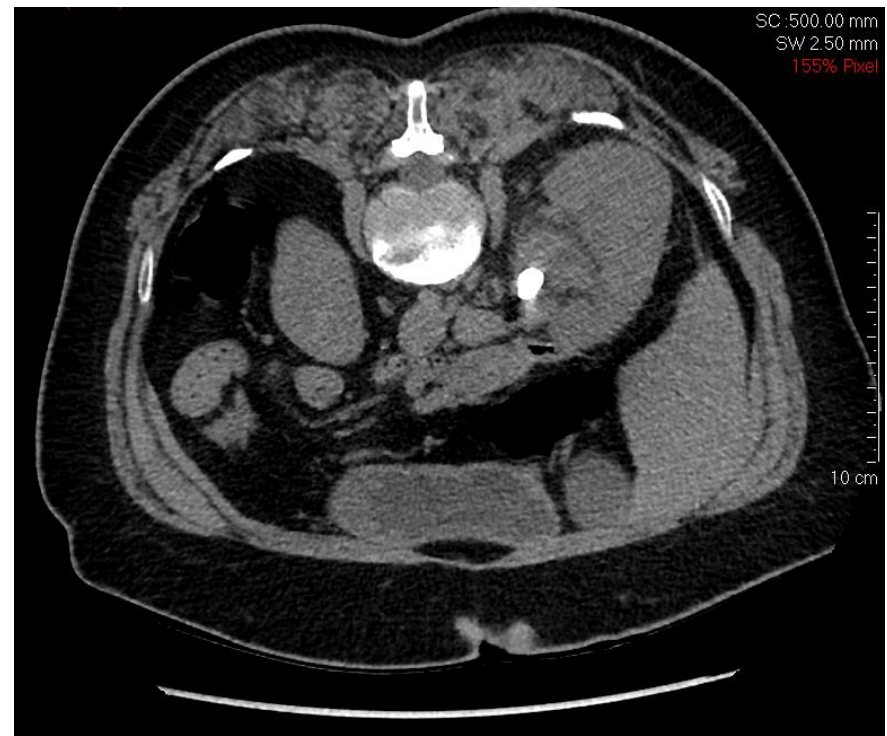


Quelle mesure proposez-vous?

- ☒ A. Drainage urétéral : sonde JJ
- ☐ B. Pyélolithotomie différée après antibiothérapie
- ☐ C. Lithotritie extra-corporelle (ESWL)
- ☐ D. Néphrolitholapaxie percutanée
- ☐ E. Dissolution du calcul

Au bout de 15 jours d'antibiothérapie, une sonde double J ayant permis de drainer l'infection urinaire, le syndrome inflammatoire est résolu.

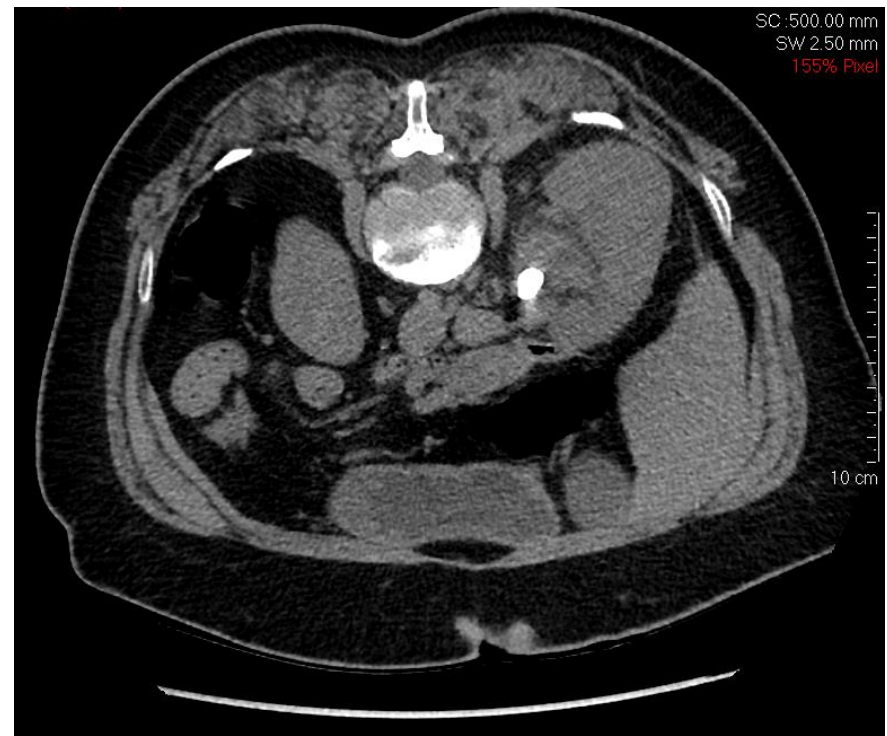
Quel traitement proposez-vous?



- ☒ A. Pyélolithotomie
- ☐ B. Lithotritie extra-corporelle (ESWL)
- ☐ C. Urétéroscopie et TT laser du calcul
- ☐ D. Néphrolitholapaxie percutanée
- ☐ E. Dissolution du calcul

Au bout de 15 jours d'antibiothérapie, une sonde double J ayant permis de drainer l'infection urinaire, le syndrome inflammatoire est résolu.

Quel traitement proposez-vous?



- ☐ A. Pyélolithotomie
- ☒ B. Lithotritie extra-corporelle (ESWL) ou
- ☒ C. Urétérofibroscopie et TT laser du calcul
- ☐ D. Néphrolitholapaxie percutanée
- ☐ E. Dissolution du calcul

Lors de vacances en Italie, un homme de 68 ans, BMI 35, constate une hématurie totale indolore, en même temps que des saignements gingivaux. Les urines sont redevenues claires par la suite et il se sent en excellente forme. Il suit une anticoagulation orale pour une fibrillation auriculaire. Quelle mesure envisagez-vous ?



A. Contrôle des urines



B. CT-scan abdominal



C. Cystoscopie



D. Optimisation du traitement anticoagulant



E. Cytologie des urines

Lors de vacances en Italie, un homme de 68 ans, BMI 35, constate une hématurie totale indolore, en même temps que des saignements gingivaux. Les urines sont redevenues claires par la suite et il se sent en excellente forme. Il suit une anticoagulation orale pour une fibrillation auriculaire. Quelle mesure envisagez-vous ?

- ☐ A. Contrôle des urines
-  ☒ B. CT-scan abdominal
- ☐ C. Cystoscopie
- ☐ D. Optimisation du traitement anticoagulant
- ☐ E. Cytologie des urines

Un jeune homme de 18 ans s'adresse aux urgences à 05:00, pour des douleurs testiculaires gauches aiguës survenues au cours de la nuit. La veille, il a fait un match de basket lors d'une compétition. A la palpation, le testicule gauche est douloureux et haut situé dans le scrotum. Quelle mesure envisagez-vous ?



A. Contrôle des urines



B. Observation clinique en division d'hospitalisation



C. Echographie scrotale



D. Prescription d'anti-inflammatoires



E. Exploration chirurgicale du scrotum

Un jeune homme de 18 ans s'adresse aux urgences à 05:00, pour des douleurs testiculaires gauches aiguës survenues au cours de la nuit. La veille, il a fait un match de basket lors d'une compétition. A la palpation, le testicule gauche est douloureux et haut situé dans le scrotum. Quelle mesure envisagez-vous ?



A. Contrôle des urines



B. Observation clinique en division d'hospitalisation



C. Echographie scrotale



D. Prescription d'anti-inflammatoires



E. Exploration chirurgicale du scrotum

Un jeune homme de 30 ans s'adresse en urgence à la PMU, pour des douleurs testiculaires droites survenues lors d'un rapport sexuel. Vous palpez un testicule droit dur et nodulaire, l'épididyme semble fin. La palpation est sensible, mais indolore. Les urines sont normales et il n'y a pas d'écoulement urétral. Quelle mesure envisagez-vous ?



A. Echographie scrotale



B. Recherche de Chlamydia



C. Azythromycin 3 x 500mg/ 3 jours



D. Prescription d'anti-inflammatoires



E. Exploration chirurgicale du scrotum

Un jeune homme de 30 ans s'adresse en urgence à la PMU, pour des douleurs testiculaires droites survenues lors d'un rapport sexuel. Vous palpez un testicule droit dur et nodulaire, l'épididyme semble fin. La palpation est sensible, mais indolore. Les urines sont normales et il n'y a pas d'écoulement urétral. Quelle mesure envisagez-vous ?

- ➡ ☒ A. Echographie scrotale
- ☐ B. Recherche de Chlamydia
- ☐ C. Azythromycin 3 x 500mg/ 3 jours
- ☐ D. Prescription d'anti-inflammatoires
- ☐ E. Exploration chirurgicale du scrotum

L'échographie scrotale révèle cette image du testicule droit.

Quel diagnostic proposez-vous?



- ☐ A. Epididymite aiguë
- ☐ B. Abscès testiculaire
- ☐ C. Tumeur du testicule
- ☐ D. Hématome post-traumatique
- ☐ E. Orchite

L'échographie scrotale révèle cette image du testicule droit.

Quel diagnostic proposez-vous?



- ☐ A. Epididymite aiguë
- ☐ B. Abscès testiculaire
- ☒ C. Tumeur du testicule
- ☐ D. Hématome post-traumatique
- ☐ E. Orchite

Les marqueurs tumoraux sont élevés : AFP: 25 (<5); β -HCG 621 (<5); LDH 277 (<225). L'indication à une orchidectomie droite est posée, et le patient vous pose la question des mesures à prendre en vu de préserver sa fertilité. Quelle mesure envisagez-vous ?

- ☒ A. Aucune, le testicule contro-latéral étant normal.
- ☐ B. Cryopréservation du sperme
- ☐ C. Mesure de la testostérone
- ☐ D. Biopsie testiculaire contro-latérale
- ☐ E. Spermogramme post orchidectomie

Les marqueurs tumoraux sont élevés : AFP: 25 (<5); β -HCG 621 (<5); LDH 277 (<225). L'indication à une orchidectomie droite est posée, et le patient vous pose la question des mesures à prendre en vu de préserver sa fertilité. Quelle mesure envisagez-vous ?

- ☐ A. Aucune, le testicule contro-latéral étant normal.
-  ☒ B. Cryopréservation du sperme
- ☐ C. Mesure de la testostérone
- ☐ D. Biopsie testiculaire contro-latérale
- ☐ E. Spermogramme post orchidectomie

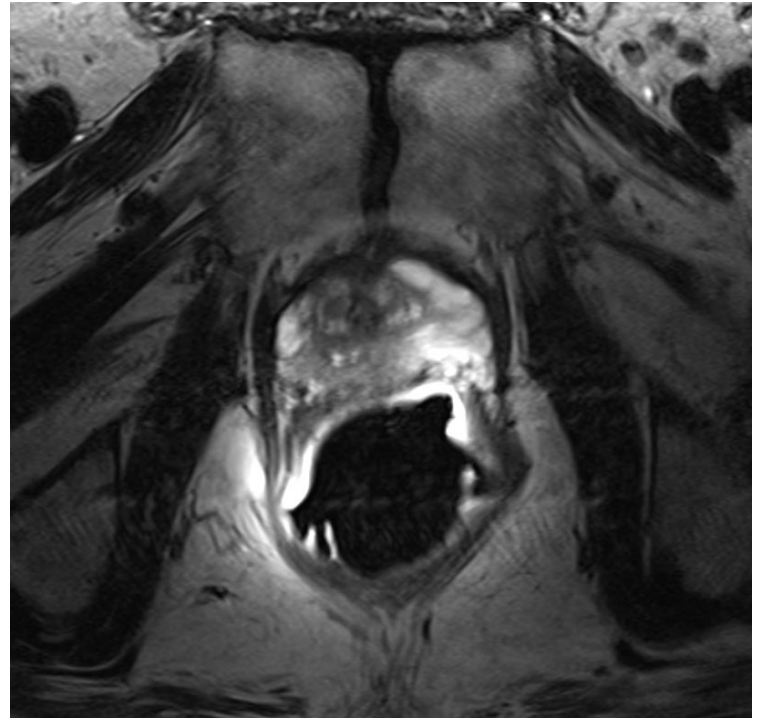
Un jeune homme de 35 ans vous demande conseil sur les mesures de dépistage du cancer de la prostate à suivre; son père de 65 ans étant en train de mourir d'une métastatisation osseuse diffuse de la maladie. Quel conseil lui prodiguez-vous ?

- ☒ A. Palpation annuelle de la prostate.
- ☐ B. Mesure du PSA à partir de 40 ans
- ☐ C. Endosonographie prostatique chaque 2 ans
- ☐ D. Biopsie prostatique initiale
- ☐ E. Aucun examen particulier

Un jeune homme de 35 ans vous demande conseil sur les mesures de dépistage du cancer de la prostate à suivre; son père de 65 ans étant en train de mourir d'une métastatisation osseuse diffuse de la maladie. Quel conseil lui prodiguez-vous ?

- ☐ A. Palpation annuelle de la prostate.
- ➔ ☒ B. Mesure du PSA à partir de 40 ans
- ☐ C. Endosonographie prostatique chaque 2 ans
- ☐ D. Biopsie prostatique initiale
- ☐ E. Aucun examen particulier

Un homme de 49 ans, ami de la famille, vous demande un avis. Des biopsies de la prostate réalisées en raison d'une élévation du PSA à 8,3 ont révélés la présence d'un adénocarcinome de la prostate bilatéral de score de Gleason 3+4=7. La glande paraît normale au TR et l'IRM endorectale montre l'image suivante.



Quel traitement lui conseillez-vous ?



A. Prostatectomie radicale



B. Brachythérapie



C. Radiothérapie externe

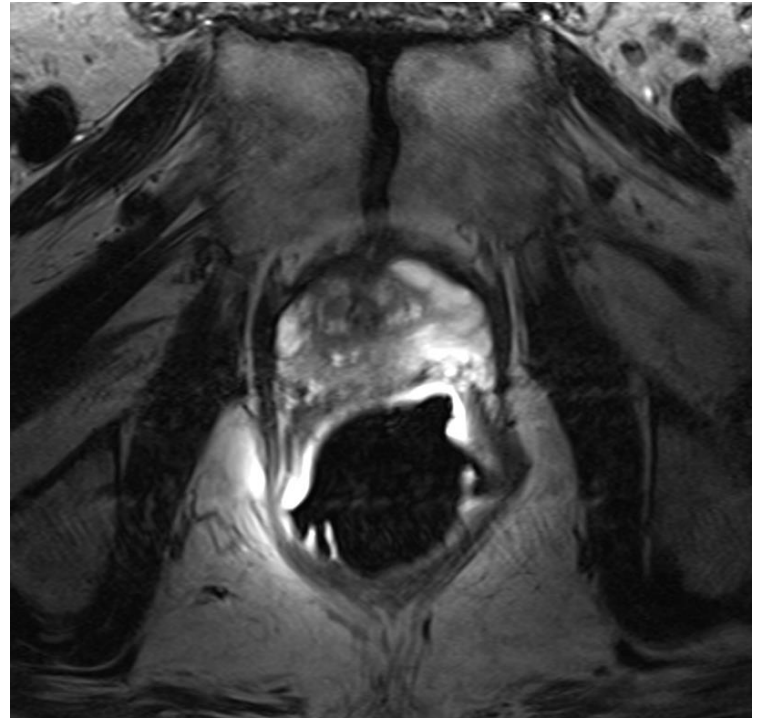


D. Hormonothérapie



E. Aucun traitement.

Un homme de 49 ans, ami de la famille, vous demande un avis. Des biopsies de la prostate réalisées en raison d'une élévation du PSA à 8,3 ont révélés la présence d'un adénocarcinome de la prostate bilatéral de score de Gleason 3+4=7. La glande paraît normale au TR et l'IRM endorectale montre l'image suivante.



Quel traitement lui conseillez-vous ?

- ☒ A. Prostatectomie radicale
- ☐ B. Brachythérapie
- ☐ C. Radiothérapie externe
- ☐ D. Hormonothérapie
- ☐ E. Aucun traitement.

Un homme de 69 ans est admis aux urgences pour une colique néphrétique gauche, sans état fébrile, associée à des nausées. Hématurie microscopique au stick urinaire. L'URO-CT natif montre un calcul de la jonction urétéro-vésicale: image suivante.



Quel traitement lui conseillez-vous?

- ☒ A. Urétéroscopie en urgence
- ☐ B. Lithotritie extra-corporelle
- ☐ C. Traitement conservateur
- ☐ D. Mise en place d'une sonde JJ pour drainer le rein
- ☐ E. Réimplantation urétérale

Un homme de 69 ans est admis aux urgences pour une colique néphrétique gauche, sans état fébrile, associée à des nausées. Hématurie microscopique au stick urinaire. L'URO-CT natif montre un calcul de la jonction urétéro-vésicale: image suivante.



Quel traitement lui conseillez-vous?

- ☐ A. Urétéroscopie en urgence
- ☐ B. Lithotritie extra-corporelle
- ☒ C. Traitement conservateur
- ☐ D. Mise en place d'une sonde JJ pour drainer le rein
- ☐ E. Réimplantation urétérale

Un homme de 74 ans, connu pour une HTA à 170/100 compliquée d'une cardiopathie ischémique qui a nécessité deux angioplasties coronarienne, constate une difficulté à initier la miction le matin, une dysurie et des gouttes retardataires. Il se lève 5 fois la nuit pour vider sa vessie. Quel examen devez-vous réaliser initialement ?



A. Ultrason abdominal



B. Toucher rectal



C. Mesure du PSA



D. Cystoscopie



E. Débitmétrie urinaire

Un homme de 74 ans, connu pour une HTA à 170/100 compliquée d'une cardiopathie ischémique qui a nécessité deux angioplasties coronarienne, constate une difficulté à initier la miction le matin, une dysurie et des gouttes retardataires. Il se lève 5 fois la nuit pour vider sa vessie. Quel examen devez-vous réaliser initialement ?



A. Ultrason abdominal



B. Toucher rectal



C. Mesure du PSA



D. Cystoscopie



E. Débitmétrie urinaire

Un homme de 35 ans consulte pour une tuméfaction aigue du testicule droit. Fièvre 37,8°. La palpation révèle un nodule douloureux de la queue de l'épididyme. Le stix urinaire montre des leuco ++. Quel examen devez-vous réaliser ?



A. Echographie testiculaire



B. Echographie abdominale



C. Mesure du PSA



D. Test HIV



E. Toucher rectal

Un homme de 35 ans consulte pour une tuméfaction aigue du testicule droit. Fièvre 37,8°. La palpation révèle un nodule douloureux de la queue de l'épididyme. Le stix urinaire montre des leuco ++. Quel examen devez-vous réaliser ?



A. Echographie testiculaire



B. Echographie abdominale



C. Mesure du PSA



D. Test HIV



E. Toucher rectal

Un homme de 65 ans, connu pour un diabète insulino-requérant depuis 20 ans, est admis pour un état fébrile. Il mentionne des mictions incontrôlées de petites quantités et une faiblesse du jet. Deux mois auparavant, son médecin l'a traité pour une infection urinaire.

Quel examen devez-vous réaliser en premier pour optimiser la prise en charge?



A. Mesure du PSA



B. Hémocultures



C. Inspection de l'abdomen



D. Examen urodynamique



E. Endosonographie de la prostate

Un homme de 65 ans, connu pour un diabète insulino-requérant depuis 20 ans, est admis pour un état fébrile. Il mentionne des mictions incontrôlées de petites quantités et une faiblesse du jet. Deux mois auparavant, son médecin l'a traité pour une infection urinaire.

Quel examen devez-vous réaliser en premier pour optimiser la prise en charge?



A. Mesure du PSA



B. Hémocultures



C. Inspection de l'abdomen



D. Examen urodynamique



E. Endosonographie de la prostate

Un homme de 78 ans, connu pour un syndrome lombo-vertébral chronique sur une arthrose dégénérative de la colonne lombaire vous consulte pour une hématurie initiale. Le toucher rectal fait état d'une prostate bosselée, dure à limites conservées. Le PSA est à 450ng/ml (<4). Une biopsie de la prostate confirme un adénocarcinome de score $4+3=7$.

Quel examen envisagez-vous pour compléter le bilan?



A. IRM de la prostate



B. Ultrason de l'abdomen



C. Scintigraphie osseuse



D. Cystoscopie



E. Examen urodynamique

Un homme de 78 ans, connu pour un syndrome lombo-vertébral chronique sur une arthrose dégénérative de la colonne lombaire vous consulte pour une hématurie initiale. Le toucher rectal fait état d'une prostate bosselée, dure à limites conservées. Le PSA est à 450ng/ml (<4). Une biopsie de la prostate confirme un adénocarcinome de score $4+3=7$.

Quel examen envisagez-vous pour compléter le bilan?

- ☒ A. IRM de la prostate
- ☐ B. Ultrason de l'abdomen
-  ☒ C. Scintigraphie osseuse
- ☐ D. Cystoscopie
- ☐ E. Examen urodynamique

Une femme de 58 ans porteuse d'une poche iléale hétérotope de dérivation urinaire pour vessie neurogène est admise en état comateux aux urgences. Le ph veineux est à 7.1, la patiente est déshydratée.

Lequel de ces désordres de l'équilibre acido-basique explique l'état comateux?

- ☒ A. Alcalose respiratoire
- ☐ B. Acidose métabolique
- ☐ C. Alcalose hypernatrémique
- ☐ D. Acidose hypercapnique
- ☐ E. -

Une femme de 58 ans porteuse d'une poche iléale hétérotope de dérivation urinaire pour vessie neurogène est admise en état comateux aux urgences. Le ph veineux est à 7.1, la patiente est déshydratée.

Lequel de ces désordres de l'équilibre acido-basique explique l'état comateux?

- ☐ A. Alcalose respiratoire
- ➔ ☒ B. Acidose métabolique
- ☐ C. Alcalose hypernatrémique
- ☐ D. Acidose hypercapnique
- ☐ E. -

Une femme de 68 ans qui a eu une curiethérapie endovaginale et une radiothérapie externe pour un adénocarcinome de l'endomètre 20 ans auparavant, consulte pour des douleurs sus-pubiennes associées à des épisodes plus fréquents d'infection urinaire.

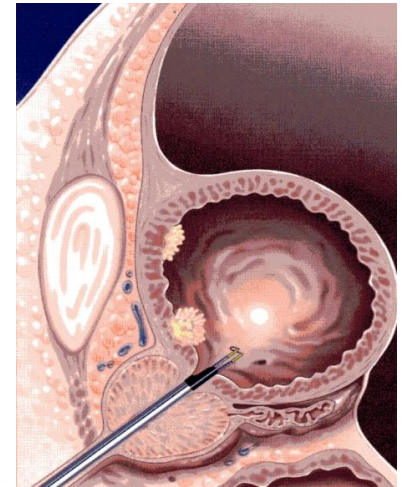
Quel diagnostic faut-il écarter?

- ☒ A. Cystite radique
- ☐ B. Cystite chronique
- ☐ C. Calcul vésical
- ☐ D. Tumeur de la vessie
- ☐ E. Syndrome urétral

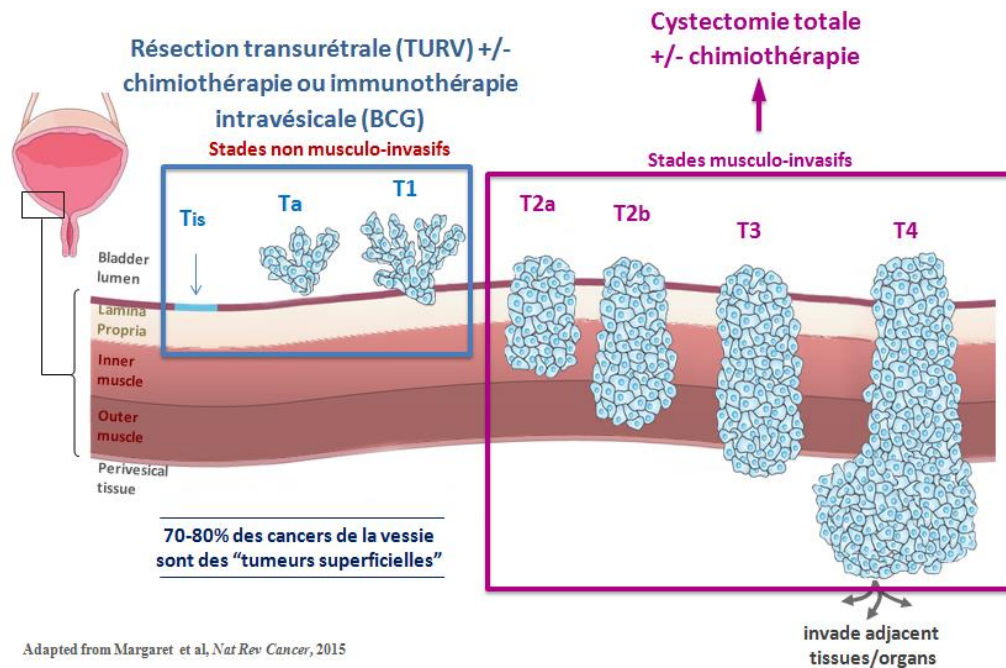
Une femme de 68 ans qui a eu une curiethérapie endovaginale et une radiothérapie externe pour un adénocarcinome de l'endomètre 20 ans auparavant, consulte pour des douleurs sus-pubiennes associées à des épisodes plus fréquents d'infection urinaire.

Quel diagnostic faut-il écarter?

- ☒ A. Cystite radique
- ☐ B. Cystite chronique
- ☐ C. Calcul vésical
-  ☒ D. Tumeur de la vessie
- ☐ E. Syndrome urétral



Prise en charge du cancer de la vessie en fonction de la stratification clinique



Un homme de 72 ans est admis en tamponnade vésicale sur une hématurie macroscopique . Le patient souffre d'une cardiopathie coronarienne sur tabagisme et a été traité pour un carcinome épidermoïde amygdalien en ORL. Le CT-scan abdominal décrit un kyste Bosniak IV du rein droit: cf. image.

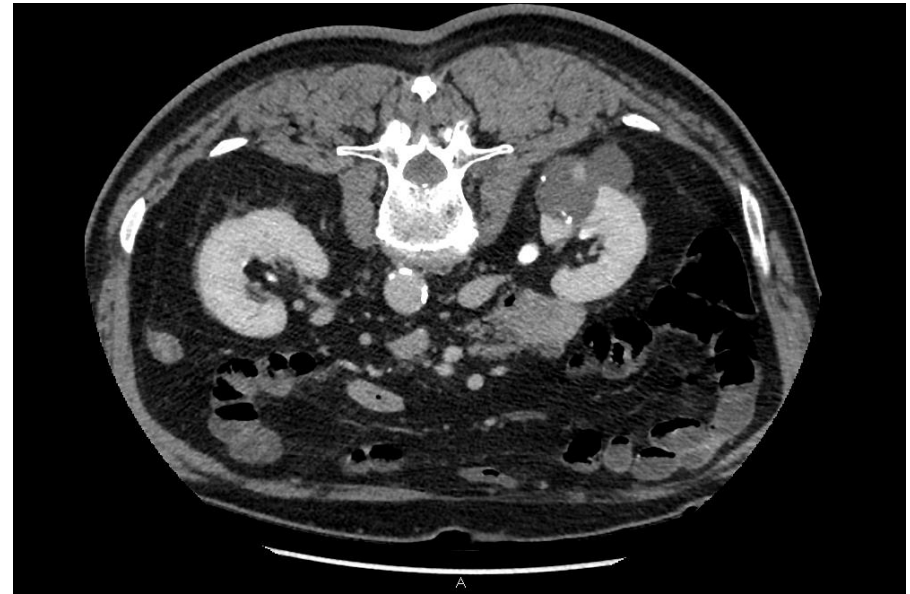
Que proposez-vous au patient ?



- ☒ A. Cystoscopie
- ☐ B. Biopsie du rein
- ☐ C. Suivi de l'évolution du kyste par ultrason
- ☐ D. Traitement par radiofréquence
- ☐ E. Néphrectomie

Un homme de 72 ans est admis en tamponnade vésicale sur une hématurie macroscopique. Le patient souffre d'une cardiopathie coronarienne sur tabagisme et a été traité pour un carcinome épidermoïde amygdalien en ORL. Le CT-scan abdominal décrit un kyste Bosniak IV du rein droit: cf. image.

Que proposez-vous au patient ?



- ➡ ☒ A. Cystoscopie
- ☐ B. Biopsie du rein
- ☐ C. Suivi de l'évolution du kyste par ultrason
- ☐ D. Traitement par radiofréquence
- ☐ E. Néphrectomie

Un jeune homme de 35 ans est admis en urgence. Il souffre d'une intense dysurie, accompagnée de ténesmes vésicaux et de l'émission de petites gouttes d'urines dont le passage est douloureux. Il frissonne, sa température est de 39°.

Parmi les mesures suivantes, laquelle est inappropriée ?

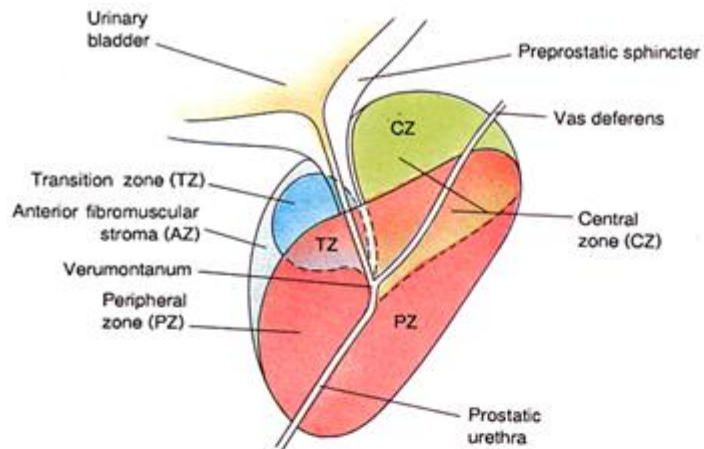
- ☒ A. Examen d'urine
- ☒ B. Massage prostatique
- ☒ C. Antibiothérapie à large spectre
- ☒ D. Formule sanguine
- ☐ E. Ultrason abdominal

Un jeune homme de 35 ans est admis en urgence. Il souffre d'une intense dysurie, accompagnée de ténesmes vésicaux et de l'émission de petites gouttes d'urines dont le passage est douloureux. Il frissonne, sa température est de 39°.

Parmi les mesures suivantes, laquelle est inappropriée ?

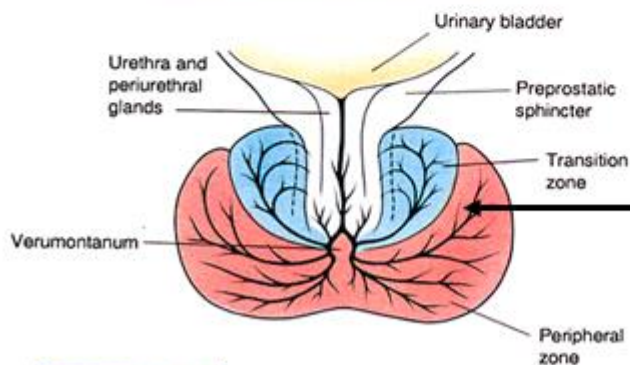
- ☐ A. Examen d'urine
-  ☒ B. Massage prostatique
- ☐ C. Antibiothérapie à large spectre
- ☐ D. Formule sanguine
- ☐ E. Ultrason abdominal

Localisation du cancer



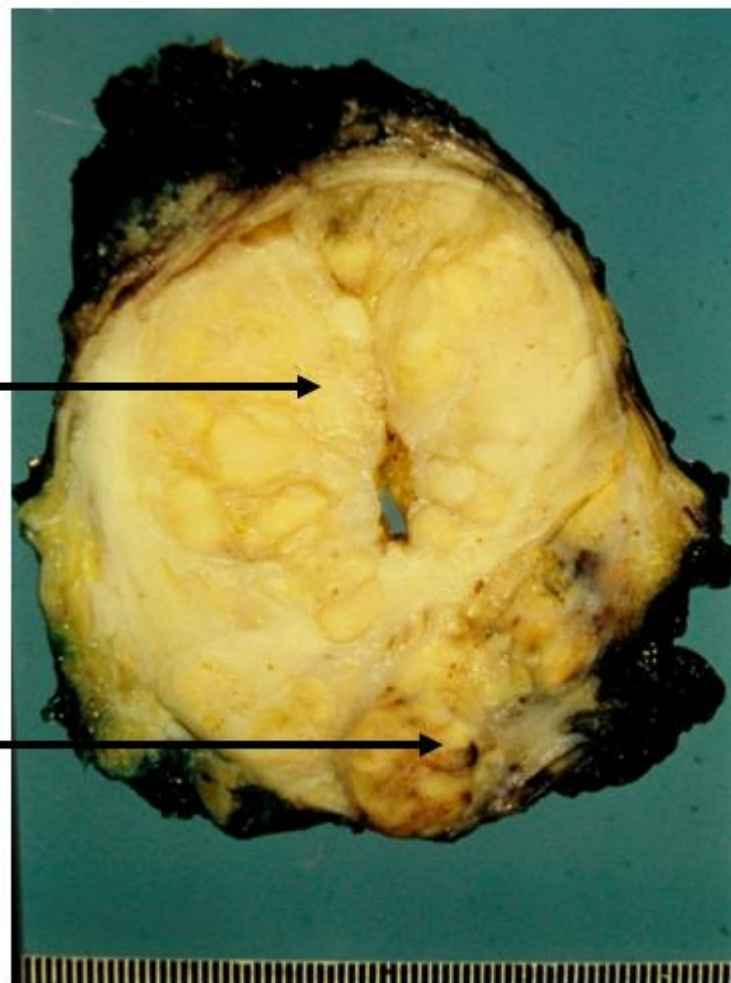
adénome

Oblique coronal plane of section through the prostate along the proximal urethra



from McNeal [1,50]

Maladie Périphérique (70%)



! Maladie aussi située dans la zone transitionnelle et antérieure!